أسئلة من كوروﻻت تانية ليها علاقة بدروس الفارماكولوجي

15

Kurul 3–6 · 2023–2024

K3-24 Dolaşım-Solunum · K4-24 Sinir-Duyu-Lokomotor · K5-24 Sindirim-Metabolizma · K6-24 Ürogenital-Endokrin

15 سؤال	**5** إجابتها في الشرح
10 للمراجعة	**10** درس

الرقم في المربع = رقم الدرس

الإجابة من ملف الشرح نفسه

إجابتها في الشرح 5

İlerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan GnRH analoğu ...	5	K6-24 · 57	01
Antiemetikler için hangisi yanlıştır? (Metoklopramid seçici D2 ...	6	K5-24 · 59	02
İnflamatuvar barsak hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar i...	12	K5-24 · 57	03
Plazminojen aktivatörü olup trombolitik tedavide kullanılan ilaç...	13	K3-24 · 7	04
Lizin antimetaboliti gibi davranarak antifibrinolitik etki göstere...	13	K3-24 · 3	05

للمراجعة · آخر الملف 10

Koryokarsinom için hangisi yanlıştır?	1	K6-24 · 3	06
Yüksek dozlarda vagotomi ve dumping sendromuna bağlı diyar...	5	K5-24 · 58	07
Rivaroksabana bağlı hayatı tehdit eden kanamanın tersine çevr...	7	K3-24 · 8	08
Kronik karaciğer hastalığı yapmayan virüsle akut hepatit: hangi...	11	K5-24 · 70	09
Glukokortikoidler için hangisi yanlıştır?	12	K6-24 · 51	10
Kalp yetmezliğinde kalp hızındaki ve renin salgısındaki kompe...	17	K3-24 · 1	11
Hangisi naproksenin farmakodinamik etkilerinden değildir?	18	K4-24 · 26	12
Ateroskleroz süreci için hangisi doğrudur?	19	K3-24 · 58	13
Organik nitratların kullanılış yerleri için hangisi yanlıştır?	19	K3-24 · 15	14
Tepe konsantrasyona 2 saatte ulaşan, etkisi 36 saate kadar sü...	19	K6-24 · 55	15

K6-24 Ürogenital-Endokrin • Soru 57

57. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir GnRH analoğudur?

A) Löprolid ✔
B) Dutasterid
C) Siproteron asetat
D) Spironolakton
E) Mesterolon

الإجابة **A** **Löprolid**

من الدرس **سلايد 17** 2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Hormonlar ve Hormon Antagonistleri

5. GnRH Analogları: GnRH; hipotalamus tarafından salgılanır ve ön hipofizi uyararak gonadotropik hormonları salgılatır;

Uzun etki süreli sentetik GnRH analogları; uygulamada geçici stimülasyondan sonra, hipofizde desentiziasyona (duyarsızlaşmaya) ve gonadotropin salgılanmasının durmasına neden olur.

Löprolid, Goserelin, Triptorelin: GnRH (gonadotropin salıverici hormon)'ın sentetik analoglarıdır, Bu ilaçlar kadınlarda meme kanseri ve endometriyozisde yararlıdır. Prostat kanserinde kullanılırlar, bu endikasyonda östrojen türevlerinin yerini almıştır.

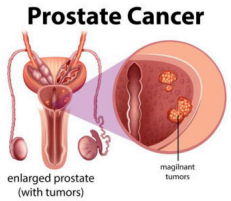
Löprolid:

(a) Sürekli salınımlı intradermal implant

(b) Deri altı depo enjeksiyon

(c) Kas içine depo enjeksiyon şeklinde kullanılır.

Goserelin asetat: deri altına implant, Triptorelin pamoat: kas içine enjeksiyon suretiyle kullanılır.



https://www.centerforurologiccare.com/patient-education/prostate-cancer/ (Erişim Tarihi: 17.11.2024)

Başlangıçta androjen düzeylerinde yükselmeye, sonrasında ise konsantrasyon seviyelerinde düşmeye neden olabilir.

Yan Etkileri: iktidarsızlık, sıcak basması, östrojen tedavisi ile yaşananlara kıyasla en az düzeydedir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 17

K5-24 Sindirim-Metabolizma • Soru 59

59. Aşağıdakilerden hangisi antiemetikler için yanlıştır?

A) Metoklopramid seçici bir dopaminerjik D2 reseptör antagonistidir ve diğer reseptörler üzerine etkinliği yoktur

B) 5-HT3 reseptör antagonistleri kemoterapiye bağlı emezisde kullanılan başlıca ilaçlardır

C) Kortikosteroidler kemoterapiye bağlı emeziste 5-HT3 reseptör antagonistlerinin etkinliğini arttırırlar

D) NK1 antagonistleri yüksek derecede emetojenik kemoterapiden kaynaklanan akut ve geç dönemdeki bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidlerle birlikte kullanılırlar

E) Histamin H1 antagonistleri (H1 antihistaminikler) hareket hastalığının tedavisinde kullanılırlar

الإجابة

A Metoklopramid seçici bir D2 antagonistidir, diğer reseptörlere etkisi yoktur

من درس 16 **سلايد 23** Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

Terapötik Amaçla Kullanılan Serotonin Agonistleri

- **SSRİ;SERT** i inhibe ederler,5-HT düzeyleri artar,**DEPRESYON** ted.kull.
- **Buspiron,Gepipiron**; Beyinde limbik sistemde **5-HT1A** reseptörlerini aktive ederek **ANKSİYOLİTİK** etki gösterir.
- **Metoklopramid;; 5-HT4** reseptör agonisti ve 5-HT3 RESEPTÖR ANTAGONİSTİDİR MİDE BOŞALMASINI HIZLANDIRIR VE **ANTİEMETİK** etkilidir.**GASTROKİNETİK.**
- **Sisaprid**; 5-HT4 reseptör agonisti. GİS reflü ve motilite bozukluklarında **PROKİNETİK** olarak kul.
- **Tageserod;** 5-HT4 reseptör agonisti. **Kabızlıkla beraber olan İRRİTABL BARSAK SENDROMUN** tedavisinde kull.

من الدرس **سلايد 24**

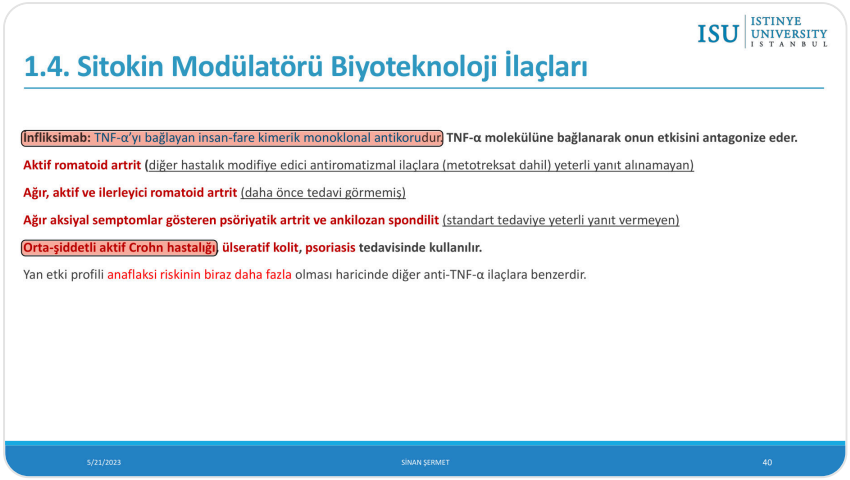
İlaç Grubu	Örnek İlaç(lar)	Mekanizma / Reseptör	Kullanım Alanı	Yaygın Yan Etki	Etki Süresi / $t_{1/2}$ (saat)
Antihistaminikler	Difenhidramin, Dimenhidrinat, Meklizin, Hidroksizin	H_1 antagonisti, vestibüler baskılama	Taşıt tutması, vestibüler bulantı	Sedasyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 4–9
Antikolinerjikler	Skopolamin	M_1 reseptör blokajı	Hareket hastalığı (profilaktik)	Ağız kuruluğu, uyku hali	Etki: 6–12 saat (transdermal 72 sa.) • $t_{1/2}$: 8
Fenotiyazinler	Prometazin, Prokloperazin, Klorpromazin	D_2 ve H_1 antagonisti (CTZ)	Kemoterapiye bağlı kusma	Ekstrapiramidal reaksiyon, antikolinerjik etki	Etki: 4–6 saat • $t_{1/2}$: 10–19
Benzamidler	Metoklopramid, Trimetobenzamid, Sisaprid	D_2 antagonisti, 5-HT_4 agonisti	Kemoterapiye bağlı kusma, gastroparezi	EPS, QT uzaması	Etki: 1–2 saatte başlar • $t_{1/2}$: 5–6
Benzimidazoller	Domperidon	D_2 antagonisti (periferik)	Gastroparezi, kemoterapiye bağlı kusma	Baş ağrısı, QT uzaması	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 7–9
5-HT_3 Reseptör Antagonistleri	Ondansetron, Granisetron, Tropisetron	5-HT_3 blokajı (CTZ + vagal afferent)	Kemoterapi, postoperatif kusma	Baş ağrısı, diyare, QT uzaması	Etki: 30 dk içinde • $t_{1/2}$: 4–10 (Granisetron 9–12)
NK_1 Reseptör Antagonistleri	Aprepitant	Substance P – NK_1 blokajı	Kemoterapiye bağlı geç faz kusma	İştahsızlık, baş dönmesi	Etki: 24 saatte maksimum • $t_{1/2}$: 9–13
Butirofenonlar	Droperidol	D_2 antagonisti (CTZ)	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Hipotansiyon, sedasyon	Etki: 30 dk • $t_{1/2}$: 2–3
Benzodiazepinler	Lorazepam, Diazepam	GABA-A agonisti; anksiyolitik, sedatif	Anticipatuar kusma, anksiyete	Sedasyon, solunum depresyonu	Etki: 1 saatte başlar • $t_{1/2}$: Lorazepam 12–15, Diazepam 30–60
Antimigren – Abortif (Triptanlar)	Sumatriptan, Zolmitriptan, Frovatriptan	5-$HT_1B/1D$ agonisti	Migren, abdominal migren, siklik kusma	Göğüs basısı, parestezi	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: Suma 2, Zolmi 3, Frova 26
NSAİİ'ler	Ketorolak	COX inhibitörü (prostaglandin ↓)	Migren, siklik kusma	GİS kanama	Etki: 30–60 dk • $t_{1/2}$: 4–6
Antimigren – Profilaktik	Siproheptadin, Pizotilin, Propranolol, Amitriptilin, Fenobarbital	H_1 / 5-HT_2 antagonisti, β-blokaj, GABA artışı	Migren ve siklik kusma önleme	Sedasyon, kilo artışı, hipotansiyon	Etki: Günlük kullanımla 1–2 haftada • $t_{1/2}$: Propranolol 4, Amitriptilin 15, Fenobarbital 80–100
Kortikosteroidler	Deksametazon	Glukokortikoid reseptör aktivasyonu	Kemoterapi ve postoperatif kusma	Adrenal supresyon	Etki: 1–2 saat • $t_{1/2}$: 36–54
Kannabinoidler	Dronabinol, Nabilon	CB_1R agonisti (vagal nörontar)	Kemoterapi kaynaklı kusma	Vertigo, halüsinasyon	Etki: 1–2 saatte • $t_{1/2}$: 25–36

Doç. Dr. Sema Ketenci Şeren 0

ملاحظات

K5-24 Sindirim-Metabolizma • Soru 57

من الدرس سلايد 40 1.4. Sitokin Modülatörü Biyoteknoloji İlaçları



الإجابة

A İnfliksimab: TNF monoklonal antikoru, dirençli orta-şiddetli Crohn'da kullanılır

57. **Aşağıdakilerden hangisi inflamatuvar barsak hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar için doğrudur?**

A) İnfliksimab bir TNF monoklonal antikorudur ve klasik tedaviye yanıt vermeyen orta veya şiddetli Crohn hastalığının tedavisinde kullanılabilir

B) Glukokortidoidler hafif inflmatuvar barsak hastalıklarının tedavisinde ilk seçenek ilaçlardır

C) 6-Merkaptopürin (6-MP) lokal olarak uygulanır ve temel olarak antiinflamatuvar özelliği ile inflamatuvar barsak hastalığı tedavisinde etkilidir

D) 5-ASA formüle edilmeden direkt uygulandığında ince barsağın distal kısmı ve kolonda yüksek konsantrasyonlara ulaşır

E) Metotreksat hafif inflamatuvar barsak hastalığı olgularında ve sadece başlangıç tedavisinde kullanılır, idame tedavisinde yeri yoktur

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 7

7. **Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazminojen aktivatörüdür ve tehlikeli damar içi pıhtıları eriterek iskemik hasarı önlemek amacıyla uygulanan trombolitik tedavide kullanılmaktadır?**

A) Reteplaz
B) Aspirin
C) Enoksaparin
D) Klopidogrel
E) Silostazol

الإجابة **A** Reteplaz

من الدرس **سلايد 16** 2. Fibrinolitik İlaçlar

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Fibrinolitik İlaçlar

Plazminojen Aktivatörleri: (1) tPA (doku plazminojen aktivatörü), **(2) uPA** (üre plazminojen aktivatörü)(**Ürokinaz**)

Plazminojen akivatörleri plazminojeni plazmine (aktif şekline) dönüştürürler.

Aktif plazmin fibrini yıkarak, fibrin yıkım ürünlerinin oluşumunu sağlar.

(1) Streptokinaz,

(2) Alteplaz* (rekombinant doku plazminojen aktivatörü rtPA), (streptokinazdan daha az alerjik yan etkili)

(3) Ürokinaz,

(4) Anistreplaz (anizoylenmiş plazminojen-streptokinaz)

(5) Reteplaz*

(6) Tenekteplaz*

***(fibrine özgü (trombüste fibrine yapışmış durumdaki plazminojeni aktive eder, kanda dolaşan serbest plazminojeni pek aktive etmezler)**

Fibrinolitik ilaçların başlıca kullanım alanları: akut MI ve koroner trombolizdir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 16

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 3

3. **Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi lizin antimetaboliti gibi davranarak plazminin fibrine bağlanmasını inhibe eder, antifibrinolitik etkiler gösterir ve kanama tedavisinde kullanılır?**

A) Traneksamik asit
B) Desmopressin asetat
C) Fitomenadion
D) Etamsilat
E) Okreotid

A **Traneksamik asit** الإجابة

من الدرس 2. Antifibrinolitik İlaçlar **سلايد 25**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

2. Antifibrinolitik İlaçlar

Traneksamik Asit: Aminokaproik asidin siklobenzil analoğudur. Etki mekanizması benzer; **lizin antimetaboliti** gibi davranarak fibrinolizi inhibe eder. **Etkisi daha güçlü** ve **daha uzun süreli**.

Aşırı fibrinoliz dahil aminokaproik asidin kullanıldığı endikasyonlarda kullanılır. Birçok endikasyonda onun yerini almıştır.

Ayrıca mide ve duodenum ülserlerinin kanamalarında. Menorajiye karşı etkilidir. Herediter ve herediter olmayan anjiyoödemde, kalp cerrahisinde, çocuklarda kraniyosinostozis rekonstriksiyonunda perioperartif kanamayı ve kan transfüzyonu gereksinimini azaltır. Ortopedik cerrahide, karaciğer transplantasyonunda, prostat ve mesane cerrahisinde kanamayı azalttığı gösterilmiştir. Travmaya bağlı kanamalı hastalarda ölümü azalttığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikleri: Ağız yolundan iyi emilir. Plazma doruk konsantrasyonuna 2 saatte ulaşır. Eliminasyon yarılanma ömrü 2 saat kadardır. Büyük kısmı böbreklerden değişmeden atılır.

Yan Etkileri: gastrointestinal bozukluklar ve alerji oluşturabilir. Renk görmeyi bozabilir (tedavi kesilir). En ciddi yan etkisi tromboembolik olaylar. Serebral iskemiye neden olur (subaraknoid kanamalarda kullanılmaz). Kas spazmları, artralji.



https://www.hekimce.com/blog/ilac-rehberi/transamine (Erişim Tarihi: 11.01.2023)

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 25

آخر الملف

للمراجعة

10 أسئلة علاقتها بالدروس مش مباشرة: إجابتها متفهمة من سلايد، أو موضوعها في درس بس الإجابة مش في ملف الشرح.

من محاضرة تانية

السؤال جاي من محاضرة في الكورول ده، بس إجابته مكتوبة في سلايد من الدروس.

مفيش إجابة في الشرح

السؤال عن دوا أو موضوع موجود في الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

K6-24 Ürogenital-Endokrin • Soru 3

3. Aşağıdakilerden hangisi koryokarsinom için yanlıştır?

A) Kemoterapiye duyarlı değildir ✓

B) Birincil lezyon kanama olarak görülebilir, belirgin kitle olmayabilir

C) Uterus normal büyüklükte olabilir

D))Beta HCG yüksektir

E) Mol hidatiformun aksine koryonu villusları oluşmamıştır

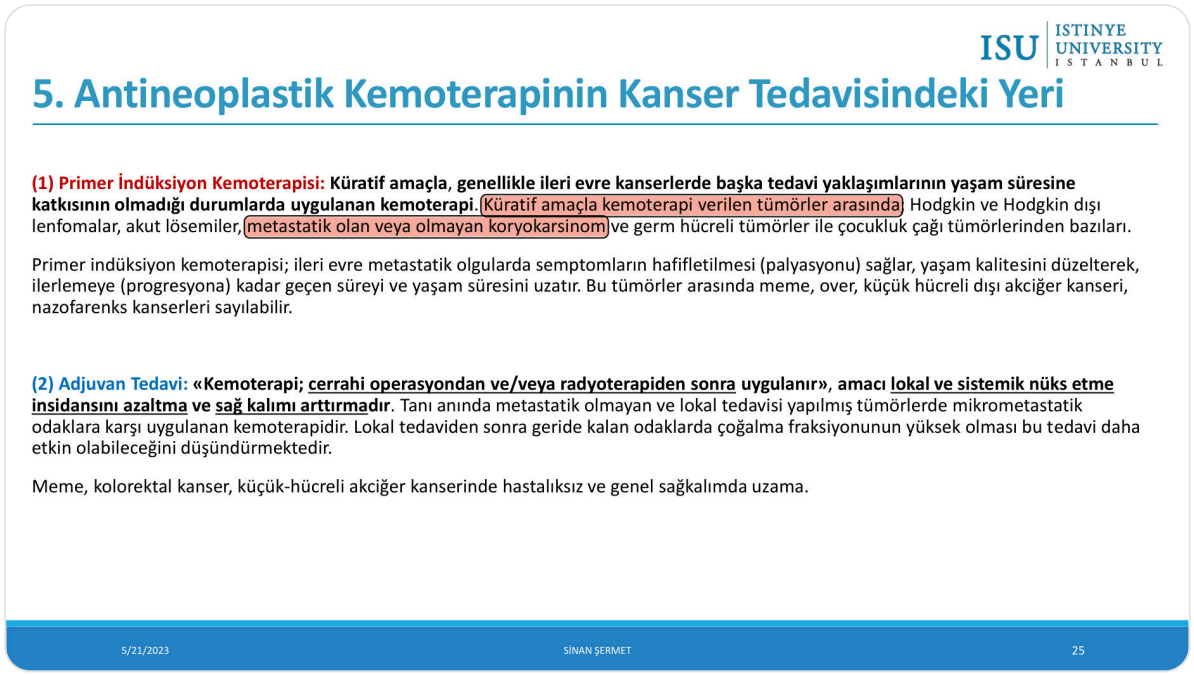
ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

سؤال باثولوجي. سلايد 25 بيعدّ الكوريوكارسينوما من الأورام اللي بيتدّى لها كيماوي بهدف الشفاء، يعني حساسة للكيماوي؛ فجملة «مش حساس للكيماوي» هي الغلط.

الإجابة

A Kemoterapiye duyarlı değildir

من الدرس **سلايد 25** 5. Antineoplastik Kemoterapinin Kanser Tedavisindeki Yeri



ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

5. Antineoplastik Kemoterapinin Kanser Tedavisindeki Yeri

(1) Primer İndüksiyon Kemoterapisi: Küratif amaçla, genellikle ileri evre kanserlerde başka tedavi yaklaşımlarının yaşam süresine katkısının olmadığı durumlarda uygulanan kemoterapi. Küratif amaçla kemoterapi verilen tümörler arasında Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, akut lösemiler, metastatik olan veya olmayan koryokarsinom ve germ hücreli tümörler ile çocukluk çağı tümörlerinden bazıları.

Primer indüksiyon kemoterapisi; ileri evre metastatik olgularda semptomların hafifletilmesi (palyasyonu) sağlar, yaşam kalitesini düzelterek, ilerlemeye (progresyona) kadar geçen süreyi ve yaşam süresini uzatır. Bu tümörler arasında meme, over, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, nazofarenks kanserleri sayılabilir.

(2) Adjuvan Tedavi: «Kemoterapi; cerrahi operasyondan ve/veya radyoterapiden sonra uygulanır», amacı lokal ve sistemik nüks etme insidansını azaltma ve sağ kalımı arttırmadır. Tanı anında metastatik olmayan ve lokal tedavisi yapılmış tümörlerde mikrometastatik odaklara karşı uygulanan kemoterapidir. Lokal tedaviden sonra geride kalan odaklarda çoğalma fraksiyonunun yüksek olması bu tedavi daha etkin olabileceğini düşündürmektedir.

Meme, kolorektal kanser, küçük-hücreli akciğer kanserinde hastalıksız ve genel sağkalımda uzama.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 25

ملاحظات

K5-24 Sindirim-Metabolizma • Soru 58

58. **Aşağıda verilen antidiyareik ilaçlardan hangisi yüksek dozlarda vagotomi ve dumping sendromu sonucu oluşan diyareye karşı etkilidir?**

A) Oktreotit
B) Loperamid
C) Difenoksilat
D) Bizmut subsalisilat
E) Eluksadolin

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
الأوكتريوتيد متشرح في سلايد 19 (أورام الغدة النخامية، الكارسينويد، دوالي المريء، القيء...)، بس استخدامه في إسهال الـ dumping مش مكتوب.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

8. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi rivaroksabana bağlı yaşamı tehdit edici veya kontrol edilemeyen kanamanın tersine çevrilmesi amacıyla kullanılmaktadır?

A) Andeksanet alfa
B) Protamin sülfat
C) Idarukizumab
D) K vitamini artı pıhtılaşma faktörleri (II, VII, IX, ve X)
E) K vitamini artı protrombin kompleks konsantresi

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 8

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
تبع موضوع مضادات التجلط (عكس مفعول الريفاروكسابان)، بس الشرح مفيهوش اسم الـ antidote؛ سلايد 6 بيقول بس إن الـ DOAC ليها antidotes خاصة.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

من الدرس Aşılar **سلايد 6**

ISU ISTINYE UNIVERSITY İSTANBUL

Aşılar

(2) İnaktif Aşılar: Üreme ve çoğalma yetenekleri yoktur, ancak antijenik özellikleri korunmuştur. Hümoral immün yanıt oluştururlar. Hücresel immün yanıt ve IgA salgısına etkileri düşüktür. Antikor titreleri zamanla azalır, bu yeterli nedenle bağışıklık yanıtı oluşması için birkaç doz uygulanmaları gerekir.

İnaktif Polio Virüs aşısı (IPV, Salk Aşısı) (inaktif virüs aşısı, üç poliovirüs serotipi formalin ile inaktive edilerek hazırlanır, i.m. veya s.c., ülkemizde 2., 4., 6., 18. ve 48. ayın sonunda uygulanır, ciddi bir yan etkiye neden olmaz, nadiren anafilaksi)

İnfluenza aşısı (4 virüs suşundan oluşur (2A ve 2B virüsü), i.m., virüsün antijenik değişikliği nedeniyle her yıl aşı içeriği belirlenir, risk gruplarına uygulanması önerilir, yan etkileri enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar, ses kısıklığı, gözlerde ağrı, kızarıklık veya kaşıntı, öksürük, ateş, miyalji, halsizlik, baş ağrısı)

Hepatit A aşısı (inaktif virüs aşısı) i.m., en erken 12. ayda uygulanır, ülkemizde çocuklara 18. ve 24. aylarda uygulanır, yan etkileri enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar, iştahsızlık, halsizlik, baş ağrısı),

Hepatit B aşısı (i.m. uygulanır, ülkemizde doğumda, 1. ve 6. ayın sonunda uygulanır, enjeksiyon bölgesinde lokal reaksiyonlar ve ateşe neden olabilir),

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 6

K5-24 Sindirim-Metabolizma • Soru 70

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

سؤال أمراض معدية: الفيروس اللي مش بيعمل مرض كبد مزمن هنا هو هيباتيتس A. سلايد 6 بيقول إن فيه تطعيم لهيباتيتس (inaktif aşı) A.

الإجابة **A** **Aşısı vardır**

70. **Otuz iki yaşında kadın hasta göz aklarında sararma idrar renginde koyulaşma ve halsizlik şikayeti ile polikliniğe başvuruyor. Enfeksiyon hastalıkları hekimi tarafından hastaya yapılan muayene ve kan tetkikleri sonucunda kronik karaciğer hastalığına yol açmayan bir virüs ile akut viral hepatit geçirdiği söyleniyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastadaki olası viral hepatit virüsü ve gelişen akut hepatit hakkında en doğrudur?**

A) Aşısı vardır ✓
B) Bir DNA virüsüdür
C) İlaçla tedavisi mümkündür
D) Hastada gelişen sarılık intravasküler hemolize bağlı indirekt bilurubin artışı nedeniyledir
E) Yiyecek ve içeceklerle bulaşmaz

K6-24 Ürogenital-Endokrin • Soru 51

51. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi glukokortikoidler için <u>yanlıştır</u>?

A) Sentetik glukokortikoidler, doğal glukokortikoidlerin mineralokortikoid etkilerini artırmak amacıyla geliştirilmiştir

B) Glukokortikoidler hiperglisemiye neden olur

C) Glukokortikoidlerin antianabolik ve katabolik etkileri vardır

D) Glukokortikoidler güçlü antiinflamatuar, antialerjik ve immünosüpresif etkilere sahiptir

E) Prednizolon sentetik bir glukokortikoiddir

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

سلايدات 24–26 بتشرح الجلوكوكورتيكويدات كمثبطات مناعة، بس مفيش كلام عن تأثيرها المينرالوكورتيكويد ولا عن الهايبرجلايسيميا.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 1

1. **Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi kalp yetmezliğinde kalp hızındaki ve renin salgısındaki kompensatuvar artışı düşürebilir?**

A) Karvedilol
B) Digoksin
C) Dopamin
D) Trandolapril
E) Kandesartan

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية
السؤال من محاضرة أدوية القلب. سلايد 15 بيقول إن السمبثاوي بيزوّد إفراز الرينين عن طريق مستقبلات β وإن البروبرانولول بيقلله؛ والكارفيديلول β-blocker برضه.

الإجابة **A Karvedilol**

من الدرس **سلايد 15** Böbrekte jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanmasının düzenlenmesi

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

Böbrekte jukstaglomerüler hücrelerden renin salgılanmasının düzenlenmesi

- **Sempatik sinir sistemi**: jukstaglomerüler hücreleri (β reseptörlerle) uyararak renin salgısını artırır. Propranol ve Klonidin renin salgı azal
- **Negatif feedback kontrol mekanizması**: AT reseptörlerini aktive ederek renin salgılanmasını inhibe eder
- **Prostaglandinler**: PGE2, PGI2 ve 6-ketoPGE1 renin salgılanmasını artırır
- **Vazopresin:** renin salgılanmasını inhibe eder
- **K+:** renin salgılanmasını inhibe eder

K4-24 Sinir-Duyu-Lokomotor • Soru 26

26. **Aşağıdakilerden hangisi naproksenin farmakodinamik etkilerden değildir?**

A) Kemik kırığının ve iskelet kasının iyileşmesini hızlandırır
B) Analjezik ve antipiretik etki gösterir
C) İnflamasyonun dört klasik semptomunu iyileştirir
D) Mide asidi salınımını arttırır ve mukus korumasını azaltır
E) Kanama zamanını uzatır

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

النابروكسين NSAID بيثبط الـ COX (سلايد 27). سلايد 129: الـ PGE2 بيعمل ألم وحرارة وبيقلل حمض المعدة (وسلايد 130: TXA2 بيزود تجمّع الصفائح)؛ فلما يقلّوا: مسكن وخافض حرارة، مضاد التهاب، حمض أكتر، ونزيف أطول. تسريع التئام الكسور مش منهم.

الإجابة

A **Kemik kırığı ve iskelet kası iyileşmesini hızlandırır**

من الدرس **سلايد 27** Siklooksijenaz Ürünleri(cox)

Siklooksijenaz Ürünleri(cox)

Siklooksijenaz enzimi, aspirin ve diğer nonsteroidal analjezik antiinflamatuvar ilaçlar tarafından inhibe edilir.

Siklooksijenaz enzimi, C vitamini ile aktive edilen ve eser element olarak bakıra ihtiyaç duyan bir enzimdir.

COX-1 damar endoteli, mide mukozası,böbrek, kalp ve trombositlerde bulunmaktadır. Buralarda koruyucu ve fizyolojik işlev görür.

İkinci izoenzim olan **COX-2** inflamatuvar uyarılarla aktive olur. Bu form makrofajlar ve diğer inflamatuvar hücrelerde bulunur ve iltihap etkenleri ile indüklenerek etkinliği arttırılır.

من الدرس **سلايد 129** Prostaglandinlerin fizyolojik etkileri

PROSTAGLANDİN	FİZYOLOJİK ETKİLER
PGE_2	Damar düz kaslarında ve bronşlarda gevşeme Duktus arteriyozusun açık tutulması Ağrı ve ateş oluşumu Gebe uterusta kasılma Renin sentezinde artma Mide asit salgısında azalma
$PGF_{2\alpha}$	Damar düz kaslarında ve bronşlarda kasılma Korpus luteumun parçalanması Progesteron düzeyinde azalma Göz içi basıncında azalma Uterusta kasılma

58. **Aşağıdakilerden hangisi ateroskleroz süreci için doğrudur?**

A) Intimal fonksiyonda endotel fonksiyonunu sağlayan önemli moderatörlerin başında nitrik oksit gelmektedir ✓

B) Fatty streak (yağlı çizgilenme) damarın adventisya tabakasında başlayarak intimaya doğru ilerler

C) Yağlı çizgilenme üzerine fibröz doku oluşarak lümene daraltacak şekilde ateroskleroz oluşması, tip 4 ateroskleroz olarak değerlendirilir

D) Aterosklerotik plakta oluşan kırılma - çatlama - hematom - trombüs non-komplike plaklar olup morbiditeye katkısı düşüktür

E) Tip 1 ateroskleroz her insanda 40 yaşından sonra oluşmaya başlayarak kardiyovasküler morbiditeye sebep vermektedir

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 58

ليه هنا؟ · من محاضرة تانية

سؤال باثولوجي/قلب عن تصلب الشرايين.
سلايد 14 بيقول إن الـ NO بيتفرز من بطانة الأوعية باستمرار، ونقصه بيساهم في الأثيروسكليروزيس، وإنه antiatherosklerotik.

الإجابة

A **Endotel fonksiyonunu sağlayan moderatörlerin başında nitrik oksit gelir**

من الدرس **سلايد 14** NO'nun Etkileri

İSÜ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL

NO’nun Etkileri

- NO trombositlerin hem agregasyonunu ve hem de adezyonunu inhibe eder, prostasiklin ve NO sinerjistik etkileşme ile **trombus oluşumunu** engeller **ANTİTROMBOTİK**
- İnsanda NO’nun bazal durumda damar endotelinden sürekli olarak salıverildiği ve vazodilatör tonus oluşturup damar rezistansının düzenlenmesine katkıda bulunduğu sanılmaktadır
- NO eksikliği **hipertansiyon, ateroskleroz ve diyabet** gibi hastalıkların patogenezine katkıda bulunur
- NO’nun mitozu inhibe ettiği bulunmuşturVasküler düz kas çoğalmasını inhibe eder **ANTİATEROSKLEROTİK**

ملاحظات

K3-24 Dolaşım-Solunum • Soru 15

15. **Aşağıdakilerden hangisi organik nitratların kullanılış yerleri için yanlıştır?**

A) Prostat hiperplazisi
B) Stabil anjina
C) Akut koroner sendrom (stabil olmayan anjina)
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Kontrollü hipotansiyon

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح

النيترات من الـ NO donors (سلايد 10–11)، وسلايد 11 بيقول إنها بتستخدم كـ antianginal و antihypertensive بس؛ باقي الاختيارات مش مذكورة، فالإجابة مش واضحة من الشرح.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**

K6-24 Ürogenital-Endokrin • Soru 55

55. Aşağıdaki PDE5 inhibitörlerinden hangisi ile tepe konsantrasyona ilacı ağızdan aldıktan 2 saat sonra erişilir; ancak seksüel aktivitenin zamanlaması, 36 saate kadar varabilen etki süresi nedeniyle daha az kritiktir?

A) Tadalafil
B) Avanafil
C) Sildenafil
D) Vardenafil
E) PDE inhibitörlerinin hepsi planlanan seksüel aktiviteden 60 dakika önce alınmalıdır

ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح
سلايد 19 و 20 بيذكروا مثبطات PDE-5 (سيلدينافيل، تادالافيل، فاردينافيل)، بس مفيش كلام عن مدة المفعول أو وقت الذروة.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**